

Capítulo 7 · Buscar y leer evidencia sin ahogarte

Deep Research, NotebookLM y lectura crítica en el tiempo que de verdad tienes.

Un paciente me preguntó por un estudio que había salido en el telediario. No lo había leído. Tardé dos minutos en tenerlo delante y diez en saber qué opinar.

Hace unos años le habría dicho "lo miro y le cuento", y no lo habría mirado: entre la noticia y el artículo hay un titular, una nota de prensa y una tarde que no tengo. Esta vez el artículo estaba en pantalla antes de que se sentara del todo.

Los diez minutos siguientes no los hizo la máquina. Los hice yo: quién entró en el estudio, cuánto duró, qué midió y qué había exagerado la tele. Le contesté con dos frases y una tercera que no sale en los telediarios: lo que aún no se sabe.

Como todas las escenas de consulta de este libro, es una composición de varias personas.

Lo que te vas a llevar

- Qué herramienta para qué pregunta: orientarse, encontrar estudios, leer lo tuyo y verificar; ninguna sustituye a PubMed, a CIMA ni a la guía en PDF.
- Una plantilla para leer un ensayo en diez minutos y la pregunta que decide: ¿esto cambia lo que hago el lunes con las personas de mi cupo?
- Un protocolo para que ninguna referencia entre en una sesión, un artículo o un libro sin que la hayas abierto.

Primera parte · Enterrada, no lejos

A PubMed entran más de un millón de artículos nuevos cada año, unos dos por minuto (Landhuis 2016). Nadie lee eso. La evidencia no está más lejos que hace veinte años: está más enterrada.

Y la pregunta llega antes que el artículo: la trae la persona, del telediario, o la trae la consulta: "¿se pierde músculo con esto?", "¿a quién derivo?", "¿el programa del centro sirve?". Antes contestaba con lo que recordaba, o no contestaba.

Ahora hago tres cosas. Convierto la duda en una pregunta que se pueda buscar. Dejo que la máquina desentierre, localice, estructure y ordene. Y leo yo lo desenterrado, con rúbrica, en el tiempo que tengo. Lo tercero cuesta lo mismo, y es lo que vale.

La máquina desentierra. Leer sigue siendo mío.

Segunda parte · Cuatro tipos de herramienta

Desenterrar, primero. "Buscar con IA" son cuatro cosas distintas; confundirlas es el error más común. Los nombres cambian cada pocos meses: comprueba la versión vigente. Varias son de pago o con cupo gratuito, y alguna pide acreditación sanitaria; lo que aquí se hace cabe en las versiones gratuitas de las tres de consumo y en PubMed [VERIFICAR OpenEvidence desde España]. En ninguna entra nada de nadie.

Tipo	Qué entra	Qué devuelve	Cuándo miente
Buscador con IA (Perplexity; Deep Research y los modos de búsqueda de Gemini, ChatGPT y Claude)	Una pregunta en lenguaje natural.	Texto redactado con enlaces a webs. Para orientarse: del titular al artículo.	Cita una web, no un estudio; resume la nota de prensa, no el ensayo.
Buscador de evidencia (Consensus, Elicit, Scite, OpenEvidence)	Una pregunta clínica.	Estudios indexados y clasificados, a veces con un "consenso". Para encontrar y ordenar.	El "consenso" se lee como metaanálisis y es un recuento de resúmenes.
Asistente con archivos o NotebookLM	Tus documentos: guías públicas, un artículo con licencia abierta, el resumen de uno de pago.	Respuestas, comparaciones y resúmenes con cita a tus fuentes.	"Recuerda" en vez de leer (capítulo 2, caso 3); el dato del medio del PDF no aparece.
PubMed y CIMA	Una cadena de búsqueda; un principio activo.	Lo que existe: el registro del artículo, la ficha técnica autorizada. Sin IA.	No mienten. Se quedan cortos: PubMed no lee por ti; CIMA dice lo autorizado, no lo último publicado.

La diferencia que más importa es la del capítulo 2 (caso 2): un buscador con IA busca y después redacta; un chat sin búsqueda redacta de memoria, con referencias con forma de verdad. Sin enlaces, no te fíes de ninguna cita.

Tercera parte · Leer con rúbrica también un artículo

Leer, después. Un resumen estructurado de un ensayo es una salida de la máquina como cualquier otra: bien escrita y capaz de equivocarse con aplomo. Las cinco preguntas del capítulo 4 le sirven tal cual:

- **Fidelidad.** ¿Dice lo que dice el artículo? Cada cifra con su página; la que no la tiene, no existe.
- **Priorización.** ¿El desenlace principal va primero? Si abre con un secundario llamativo, ha enumerado, no leído.
- **Calibración.** ¿El efecto lleva su intervalo de confianza, y en cifras absolutas, no solo relativas? Una cifra sola es un titular; un porcentaje relativo, dos.
- **Confusores.** ¿Quién entró, contra qué se comparó, quién lo pagó?
- **Acción segura.** ¿Cambia lo que hago el lunes con las personas de mi cupo? Si no, es cultura. Si sí, se lee entero y se integra con la experiencia y con lo que quiere la persona (Sackett 1996).

El itinerario de herramientas y leer un artículo con la rúbrica de una salida los traigo de mi formación en IA; el "qué cambia el lunes" es de esta consulta.

Siete casos para buscar y leer

Mismo molde que en los capítulos 4 a 6; ninguno admite datos identificables. POR ACLARAR la contestas tú fuera del chat; [FALTA: ...] lo rellenas tú fuera de la IA (capítulo 3). El modelo no rellena ninguno.

No tengo herramienta con acuerdo de tratamiento de datos, como la mayoría: aquí entran preguntas generales, documentos públicos, resúmenes de PubMed y tablas agregadas que construyes tú; ninguna persona. Conversación nueva y memoria apagada. Los siete se pegan en Gemini, ChatGPT y Claude; cada caso dice su herramienta, y el 5 abre con un paso 0 que para, como el caso 6 del capítulo 1. Ficha del capítulo 4, caso 7.

Caso 1 · De la duda a la pregunta PICO

Momento: consulta. **Herramienta:** consumo, sin búsqueda; después, PubMed y un buscador de evidencia.

Situación. "¿Se pierde músculo con el tratamiento farmacológico de la obesidad, y qué lo evita?" Es una duda de consulta, no una pregunta de búsqueda. La diferencia son cuatro letras: población, intervención, comparador, desenlace (Richardson 1995).

ROL: Eres una documentalista clínica que ayuda a médicas de familia a formular preguntas de búsqueda. No respondes preguntas clínicas: las formulas.

CONTEXTO: Soy médica de familia en España. Tengo una duda de consulta, general, sin ninguna persona detrás. LO QUE SÉ, con mis palabras: [por ejemplo: al bajar de peso se pierde algo de masa magra, con dieta y con fármacos]. LO QUE BUSCO: [por ejemplo: cuánta masa muscular se pierde con el tratamiento farmacológico de la obesidad en adultos y qué la conserva: ejercicio de fuerza, proteína].

TAREA, en este orden:

(1) La pregunta en formato PICO, una línea por letra: Población; Intervención; Comparador; Desenlace medible (qué se mide, con qué y en cuánto tiempo). Si LO QUE BUSCO mezcla dos preguntas, sepáralas y numera dos PICO.

(2) Por cada PICO, TRES CADENAS DE BÚSQUEDA, cada una en una sola línea para copiar y pegar: (a) para PubMed, con AND/OR, términos MeSH marcados [MeSH] y sus sinónimos en texto libre; (b) en inglés y en lenguaje natural, una frase, para un buscador de evidencia; (c) en español, una frase, para orientarme en un buscador con IA.

(3) LO QUE LA PREGUNTA NO CUBRE: lo que alguien creería que responde y no (otras poblaciones, otros desenlaces, seguridad, coste, a quién se indica).

FORMATO: (0) Primera línea: "DUDA SIN DATOS" o "DUDA CON DATOS: BORRA ESTA CONVERSACIÓN" si LO QUE SÉ o LO QUE BUSCO contienen un nombre, una edad exacta, una fecha o cualquier dato de una persona; en ese caso, para. Después (1), (2) y (3), sin preámbulo ni nota final. Última línea, literal: "PICO: [n] · CADENAS: [n, tres por PICO] · TÉRMINOS MeSH PROPUESTOS: [n], todos por comprobar en el MeSH Browser · NO CUBRE: [n]".

RESTRICCIONES: No respondas la pregunta clínica, ni en una frase ni dentro de "NO CUBRE". Sin cifras de eficacia. Sin nombres de fármacos, comerciales ni de principio activo: si hace falta, por mecanismo o clase. No inventes términos MeSH: si dudas, ponlo en texto libre sin [MeSH]. No busques en internet. No incluyas ni pidas datos de personas.

Ejemplo abreviado de salida.

DUDA SIN DATOS PICO 1. P: adultos con obesidad, y aparte los mayores de 65. I: fármaco para la obesidad, por clase, con dieta. C: la misma dieta con placebo. D: proporción del peso perdido que es masa magra (DXA) y fuerza de prensión o función física, a 6-12 meses. PICO 2. P: los mismos, con el fármaco. I: ejercicio de fuerza o más proteína, añadidos. C: fármaco solo. D: los mismos. (a) PICO 1: ("Anti-Obesity Agents"[MeSH] OR "weight loss medication") AND ("Body Composition"[MeSH] OR "lean mass" OR "muscle mass") · PICO 2: ("Anti-Obesity Agents"[MeSH] OR "weight loss medication") AND ("Resistance Training"[MeSH] OR "protein intake") AND ("lean mass" OR "muscle mass") NO CUBRE: mayores de 75; bioimpedancia en consulta; seguridad; a quién se indica. PICO: 2 · CADENAS: 6 · TÉRMINOS MeSH PROPUESTOS: 3, todos por comprobar en el MeSH Browser · NO CUBRE: 4

Qué revisar antes de usarla. Los términos MeSH, uno por uno, en el MeSH Browser: los modelos etiquetan sinónimos como MeSH, uno de cada cuatro. Pega la (a) en PubMed: cero resultados es un término mal escrito;

miles, que falta el desenlace. La (b) y la (c), solo para orientarte. Si ha contestado "de paso", no lo leas: es memoria, no búsqueda.

Lo que la máquina no pregunta y tú sí: por qué lo pregunta esta persona. Y función antes que masa: en tu consulta no hay DXA, pero sí un dinamómetro y una silla (capítulo 8).

Riesgo principal y mitigación. Que la pregunta bien formulada parezca ya respondida. Mitigación: "NO CUBRE" te recuerda qué no vas a saber.

Caso 2 · Tres guías, una pregunta: coincidencias y discrepancias con cita [AP]

Momento: consulta. **Herramienta:** NotebookLM o asistente con archivos, con guías públicas cargadas.

Situación. Muchas dudas no necesitan PubMed: están en las guías que ya tienes. Aquí, la misma pregunta a tres; lo que importa es dónde no coinciden. Solo documentos públicos de su web oficial, para uso personal: la GIRO 2024 de la SEEDO, la canadiense (Wharton 2020) y la NICE NG246 (Overweight and obesity management, 14 de enero de 2025).

ROL: Eres una documentalista clínica que compara guías. Trabajas solo con las fuentes cargadas; lo que sepas por tu cuenta no cuenta.

CONTEXTO: Las fuentes cargadas (cuaderno o adjuntos) son tres guías públicas sobre obesidad en personas adultas, descargadas de sus webs oficiales para uso personal: [por ejemplo: GIRO 2024 (SEEDO); Wharton 2020 (CMAJ); una tercera guía nacional o europea]. No contienen datos de pacientes. PREGUNTA: [por ejemplo: ¿qué criterios da cada guía para derivar desde Atención Primaria a una unidad o consulta especializada de obesidad?].

TAREA: (1) Busca la respuesta a la PREGUNTA en cada guía por separado. (2) Una tabla con una columna por guía y una fila por criterio; en cada celda, la cita literal entre comillas, sin resumir, y su número de cita o página; si está en otro idioma, la traducción debajo, marcada como tuya. Si una guía no dice nada sobre ese criterio, escribe en la celda "NO LO DICE". (3) Debajo de la tabla, tres filas con estos títulos: "COINCIDEN" (filas de la tabla sin ninguna celda "NO LO DICE" cuyas tres citas dicen lo mismo; nombra la fila), "DISCREPAN" (filas en las que difieren, con las cifras o palabras que difieren) y "NO LO DICE NINGUNA" (lo que la PREGUNTA esperaría encontrar y ninguna trae).

FORMATO: (0) Una línea: "FUENTES: [n] · [títulos que ves]"; si no puedes leer alguna entera, añade "LECTURA PARCIAL" y cuál. Si no son tres guías clínicas o alguna contiene datos de personas, escribe "FUENTES NO VÁLIDAS" y para. Después la tabla y las tres filas, nada más. Última línea, literal: "CITAS LITERALES: [n] · CELDAS 'NO LO DICE': [n] · CRITERIOS EN 'COINCIDEN': [n]": cada celda con comillas cuenta una cita; los dos primeros suman las celdas de la tabla.

RESTRICCIONES: Solo las fuentes cargadas: no completes con otras guías, con "la práctica habitual" ni con lo que sepas. No decidas a quién derivar ni recomiendes nada: eso lo decido yo. Si una guía usa nombres comerciales de fármacos, sustitúyelos por el principio activo. Usa "persona con obesidad". No incluyas ni pidas datos de personas.

Ejemplo abreviado de salida.

FUENTES: 3 · GIRO 2024 · Wharton 2020 · NICE NG246 | Falta de respuesta al tratamiento en el primer nivel | "[cita literal]" [cita 4] | "[cita literal]" [cita 11] | "[cita literal]" [cita 15] | [...] COINCIDEN (fila "Falta de respuesta"): [criterio, con sus tres citas]. DISCREPAN (fila "IMC y comorbilidad"): [umbral o plazo que difiere]. NO LO DICE NINGUNA: [lo que ninguna trae]. CITAS LITERALES: 7 · CELDAS 'NO LO DICE': 2 · CRITERIOS EN 'COINCIDEN': 1

Qué revisar antes de usarla. Abre cada cita y lee la frase entera con la anterior y la siguiente: NotebookLM cita bien casi siempre, y "casi" no vale. Un "NO LO DICE" en una guía que sí lo dice es "mal buscado": segundo turno sobre el apartado que tú conoces (capítulo 2, caso 3). "DISCREPAN" es el valor de la tabla: un umbral distinto suele ser un sistema sanitario distinto, no un error.

"NO LO DICE NINGUNA" es lo que decides tú sin guía. Con adjuntos en vez de cuaderno, rellenan con lo que saben; "LECTURA PARCIAL" dice si han leído entero. La tabla ordena la derivación programada; la que no espera, la de la sospecha de causa o de complicación, la sabes tú, y va al capítulo 8.

Riesgo principal y mitigación. Que "COINCIDEN" se lea como criterio propio y salga en una interconsulta. Mitigación: la interconsulta es el capítulo 5 y la decisión, el 8; esta tabla es lectura.

Caso 3 · Un ensayo en diez minutos

Momento: docencia. **Herramienta:** asistente con archivos; el PDF solo si tiene licencia abierta; si no, su resumen de PubMed: entonces la mayoría de los campos dirán NO ESTÁ EN EL DOCUMENTO, y eso también es una lectura.

Situación. Un ensayo tiene cuarenta páginas con el suplemento, y esa tarde no la tengo. La plantilla sigue el orden de CONSORT (Schulz 2010) y cabe en las once preguntas de CASPe (Cabello 2005).

Tres documentos, tres reglas. Una guía pública de su web oficial se sube para uso personal. Un artículo con licencia Creative Commons, y lo dice en su primera página, también. Un artículo de pago, aunque la suscripción del hospital te lo abra o el editor lo deje leer gratis, no: se sube el resumen de PubMed.

El ejemplo usa un ensayo con licencia abierta de semaglutida, a la dosis de obesidad, frente a placebo durante dos años (Garvey 2022), elegido por su licencia y no por el fármaco. A quién se indica lo decide el capítulo 8.¹

¹ Declaración de transparencia: mantengo vínculos con Novo Nordisk, detallados al inicio del libro. Aquí los fármacos aparecen por principio activo o por clase, solo para leer un ensayo, elegido por su licencia abierta y no por el fármaco; a quién se indican y cómo se sigue va en el capítulo 8.

ROL: Eres una epidemióloga que extrae datos de un ensayo clínico sin opinar.

CONTEXTO: Te adjunto el PDF de un ensayo clínico con licencia abierta, o su resumen, sobre un fármaco para la obesidad. Sin datos de personas; no añadas ninguno. MI CUPO, en rangos, sin nadie: [por ejemplo: adultos de 40 a 75 años, obesidad de grados I a III, muchos con hipertensión o diabetes tipo 2, en España].

TAREA: Rellena esta plantilla solo con el documento: DISEÑO (tipo, enmascaramiento, duración, registro); POBLACIÓN (inclusión y exclusión, n, edad, sexo, IMC, comorbilidades, países) y "¿SE PARECE A MI CUPO?" con las diferencias concretas; COMPARADOR y CO-INTERVENCIÓN en los dos grupos (dieta, actividad, consejo y frecuencia); DESENLACE PRINCIPAL, literal; SECUNDARIOS, primero los que importan a la persona (función, calidad de vida, eventos) o "NINGUNO"; TAMAÑO DEL EFECTO del principal, con intervalo de confianza y diferencia entre grupos; RESPONDEDORES por grupo en cada umbral del artículo; PÉRDIDAS por grupo y tipo de análisis (con o sin datos de quien dejó el fármaco); EFECTOS ADVERSOS por grupo (n de N y porcentaje), abandonos por efectos adversos y graves; QUÉ PASA AL SUSPENDER (seguimiento sin fármaco, si lo hay); FINANCIACIÓN y conflictos de interés declarados; LO QUE EL RESUMEN NO DICE (datos del texto que el resumen no trae).

FORMATO: (0) "Documento: [título] · Páginas que veo: [n]"; si no lees el archivo entero, "LECTURA PARCIAL" y hasta dónde; si solo hay resumen, "SOLO RESUMEN". Después la plantilla, cada dato con "(p. [n], apartado o tabla)". Dato que no está en lo leído: "NO ESTÁ EN EL DOCUMENTO", aunque lo sepas de memoria. Última línea, literal: "DATOS QUE NO ESTÁN EN EL DOCUMENTO: [n] · CIFRAS CON PÁGINA: [n] · CIFRAS SIN PÁGINA: [n]"; cifra es cada número con unidad o porcentaje; la última tiene que ser 0.

RESTRICCIONES: Solo el documento: nada de otros ensayos ni guías. Sin recomendaciones; no digas a quién se indica ni lo compares con otros. Fármaco por principio activo; sustituye el nombre comercial. Copia cada cifra con su unidad, sin redondear. No incluyas ni pidas datos de personas.

Ejemplo abreviado de salida (Garvey 2022; [VERIFICAR en el PDF: pérdidas por grupo, figura 1; frase literal de financiación]).

Documento: Two-year effects of semaglutide... (STEP 5) · Páginas que veo: 9 DISEÑO. Aleatorizado, doble ciego, con placebo, 104 semanas, NCT03693430 (p. [n], Methods). POBLACIÓN. 304 adultos sin diabetes, en 5 países con España; 77,6 % mujeres; edad media 47,3 años; IMC medio 38,5 (p. [n], tabla 1). ¿SE PARECE A MI CUPO? Poco: más joven, más mujeres, sin diabetes. COMPARADOR. Placebo; en los dos grupos, consejo cada 4 semanas, déficit de 500 kcal/día y 150 min/semana (p. [n], Methods). TAMAÑO DEL EFECTO. Peso a la semana 104: -15,2 % frente a -2,6 %; diferencia -12,6 puntos (IC 95 %: -15,3 a -9,8) (p. [n], tabla 2). RESPONDEDORES ≥ 10 %: 61,8 % frente a 13,3 % (misma tabla). PÉRDIDAS. Completaron 282 de 304 (92,8 %); por grupo, [n] y [n] (p. [n], figura 1); dos análisis, con y sin datos tras dejar el fármaco (p. [n], Methods). EFECTOS ADVERSOS. Digestivos: 125 de 152 (82,2 %) frente a 82 de 152 (53,9 %); abandonos por efectos adversos: 5,9 % frente a 4,6 %; graves: 7,9 % frente a 11,8 % (p. [n], tabla 3). QUÉ PASA AL SUSPENDER: NO ESTÁ EN EL DOCUMENTO.

FINANCIACIÓN. Novo Nordisk; tres autores son empleados de la compañía (p. [n], Competing interests). LO QUE EL RESUMEN NO DICE: las pérdidas y los dos tipos de análisis. DATOS QUE NO ESTÁN EN EL DOCUMENTO: 1 · CIFRAS CON PÁGINA: 29 · CIFRAS SIN PÁGINA: 0

Qué revisar antes de usarla. Tres cifras al azar, el PDF abierto por la página que dice; una, de PÉRDIDAS o de EFECTOS ADVERSOS, donde la máquina rellena de memoria. Si una falla, ninguna vale. "¿SE PARECE A MI CUPO?" la contestas tú con la tabla 1 delante: importa quién no entró.

FINANCIACIÓN se copia con nombre y apellidos, como todo lo demás: si el ensayo lo paga el laboratorio con el que colaboro, aquí lo pone, y se lee con la misma plantilla que cualquier otro. Para eso está la casilla.

La media no es nadie: cuántos de cada diez llegaron al umbral y cuántos no; a estos se les valora la retirada a los meses (capítulo 8). De dos análisis, primero el que cuenta a todos los aleatorizados, dejaran o no el fármaco. El -12,6 frente a placebo es fármaco añadido a un programa de dieta y actividad con consejo mensual que mi cupo no tiene.

Y 104 semanas sin seguimiento tras dejar el fármaco no dicen qué pasa el lunes de dentro de dos años en una enfermedad crónica. En la extensión del STEP 1, ensayo de pago con resumen libre (Wilding 2021), un año sin fármaco devolvió dos tercios del peso perdido (Wilding 2022). La acción segura, aquí: no cambio nada con un solo ensayo.

Riesgo principal y mitigación. Que el resumen sustituya al artículo y las cifras viajen sin página a una diapositiva. Mitigación: "(p. n, apartado o tabla)" en cada cifra, "CIFRAS SIN PÁGINA: 0" y tres comprobadas a mano.

Caso 4 · Del titular al artículo [AP]

Momento: divulgación y consulta. **Herramienta:** buscador con IA (Perplexity o el modo de búsqueda de tu asistente, activado); después, PubMed.

Situación. "He visto en la tele que cenar tarde engorda." En dos minutos, el estudio original, no la noticia. En diez, dos frases para la persona: lo que se vio, en quién y lo que la noticia estiró. La respuesta suele decirse; escribirla lo decides tú antes, en ENTREGA.

ROL: Eres una documentalista científica que localiza, buscando en internet, el estudio original detrás de una noticia.

CONTEXTO: Soy médica de familia en España. Una persona me pregunta por un estudio que vio en un medio; sus palabras, sin ningún dato suyo. LO QUE HA OÍDO: [por ejemplo: "que han descubierto que cenar tarde engorda"]. MEDIO Y FECHA: [por ejemplo: telediario, esta semana]. ENTREGA: [oral por defecto / escrita, solo si el estudio no toca síntomas ni tratamientos: lo decido yo].

TAREA, en dos turnos:

PASO A (solo esto en tu primera respuesta): (0) una línea: "PREGUNTA SIN DATOS" o "PREGUNTA CON DATOS: BORRA ESTA CONVERSACIÓN" si LO QUE HA OÍDO contiene nombre, edad exacta, tratamiento propio o cualquier dato personal; en ese caso, para. (1) Una cadena de búsqueda de una línea para PubMed. (2) El estudio original que mejor encaja (si dudas, dos): primer autor, año, revista, DOI y enlace al artículo (doi.org, PubMed o la revista), nunca a la noticia; y la línea "HE BUSCADO EN INTERNET: SÍ / NO"; si no hay ninguno, "NO LOCALIZADO". Para: escribiré "continúa".

PASO B: (3) QUÉ DICE EL ESTUDIO, tres líneas: diseño y tamaño; en quién; resultado principal con cifra absoluta e intervalo si los hay. (4) QUÉ DIJO EL TITULAR Y QUÉ NO CUADRA, dos líneas. (5) RESPUESTA PARA LA PERSONA, dos frases en usted, sin cifras ni consejo: qué se vio, en quién y qué falta por saber.

FORMATO: Si ENTREGA es escrita, (5) termina, literal, con "Si tiene dudas, [FALTA: contacto del centro]." y "Material informativo generado con apoyo de IA y revisado por su profesional sanitario. No sustituye la valoración clínica individual."; no añadas ninguna línea de urgencias, de síntomas ni de "consulte con su médico", aunque te parezca prudente. Última línea del paso B, literal: "ESTUDIOS: [n] · CIFRAS EN (3): [n] · CIFRAS EN (5): 0".

RESTRICCIONES: Sin nombres comerciales: principio activo o clase. No recomiendes empezar, dejar ni cambiar nada. Sin culpa ni "no debería creer lo que ve". Sin DOI inventados: si falta, "SIN DOI". No incluyas ni pidas datos de personas.

Ejemplo abreviado de salida.

PREGUNTA SIN DATOS PASO A. Cadena para PubMed: (late eating OR meal timing) AND (obesity OR weight gain). Estudio: Vujović, 2022, Cell Metabolism, doi:10.1016/j.cmet.2022.09.007 · enlace: [doi.org o PubMed]. HE BUSCADO EN INTERNET: SÍ. PASO B. QUÉ DICE EL ESTUDIO. Ensayo cruzado aleatorizado, 16 adultos con sobrepeso u obesidad, [duración], en laboratorio [VERIFICAR n y duración]; más hambre y menos gasto con la comida tardía, [cifra del artículo]. QUÉ DIJO EL TITULAR. "Cenar tarde engorda"; midió hambre y gasto durante días, no kilos durante meses. RESPUESTA PARA LA PERSONA. Se ha visto, en un grupo pequeño y durante pocos días, que comer tarde da más hambre al día siguiente. Lo que no se sabe es si eso cambia el peso a la larga. ESTUDIOS: 1 · CIFRAS EN (3): 3 · CIFRAS EN (5): 0

Qué revisar antes de usarla. El DOI en el navegador antes de "continúa": si lleva a otro artículo, o a nada, se empieza en otra herramienta. Enlace a un medio o a una nota de prensa: no ha abierto el artículo, y hoy es lo

habitual; pega el DOI o el título en PubMed. Si hace el paso B sin esperar tu "continúa", no lo leas: repite.

Si la escribes, es material informativo: las dos líneas literales del capítulo 4 y tu nombre. Si el estudio toca síntomas o un tratamiento, se dice, como los guiones del capítulo 6; lo has decidido tú antes, no la máquina. Y si añade "consulte con su médico", bórralo: es la tercera fórmula que el libro no admite.

Riesgo principal y mitigación. Que la máquina "encuentre" el estudio que la noticia inventó, o resuma la nota de prensa como artículo. Mitigación: el DOI abierto por ti antes del paso B; enlace al artículo, nunca a la noticia.

Caso 5 · Mis datos, agregados: el antes y después del programa del centro [AP]

Momento: seguimiento de crónicos. **Herramienta:** consumo, mejor si ejecuta código; tablas agregadas hechas en el centro.

Situación. Hasta aquí, evidencia de otros; ahora, la tuya. El programa de obesidad del centro lleva un año y alguien pregunta si sirve. Continúa el caso 6 del capítulo 1, con sus tres gestos, que valen igual con medias:

- **Antes de sacar nada**, la política de datos del centro o su delegado de protección de datos: el programa es del centro y las tablas se cruzan por trimestre.
- **Las tablas las haces tú**, en la hoja de cálculo del centro; el listado se queda allí.
- **Antes de subir nada**, "<5" en cualquier recuento menor de 5 y en cualquier media o mediana sobre menos de 5 personas, que es casi el dato de una; trimestres, nunca fechas; categorías, nunca cifras de peso; y tus ojos por las tablas: sin nombres, códigos ni texto libre.

La máquina describe y, sobre todo, lista lo que no se puede concluir (capítulo 5, caso 6: inventa tendencias y causas).

ROL: Eres una analista de datos que apoya a una médica de familia. Describes; ni causas ni recomendaciones.

CONTEXTO: Te pego dos tablas agregadas por trimestre del programa de obesidad de mi centro, hechas por mí fuera de la IA. Sin filas: cada celda es un recuento, una media o una mediana; los recuentos menores de 5, y toda media o mediana sobre menos de 5 personas, ya aparecen como "<5". Tabla 1: personas en el programa; con visita en el trimestre; por categoría de IMC (obesidad_1/obesidad_2/obesidad_3/sin dato). Tabla 2, con su n: mediana de HbA1c en quienes tienen diabetes; media de tensión sistólica; sin visita en dos trimestres seguidos.

TAREA:

PASO 0 (solo esto): por cada tabla, columnas y valores distintos. Marca SOSPECHOSO todo valor que no sea trimestre, categoría o número (texto libre, fechas, nombres, códigos, un n menor de 5); si lo hay, "TABLAS CON DATOS: BORRA ESTA CONVERSACIÓN", cuál, y para. Si no, "Tablas comprobadas: solo agregados, sin identificadores" y espera mi "continúa".

PASO 1: (1) LECTURA DESCRIPTIVA, máximo seis frases: qué sube, baja o se mantiene, con cifra y n. (2) LO QUE NO SE PUEDE CONCLUIR, una frase por punto con la cifra que lo muestra, o "no se ve aquí": sin grupo de comparación; regresión a la media; quién falta en cada numerador y si es quien iba peor; quién entró (selección); cambio de composición; estación del año; tratamientos empezados en el periodo; quién midió y con qué; medias que ocultan a quien empeora; otros que veas. (3) QUÉ DATO PEDIRÍA, tres líneas.

FORMATO: Paso 0; después (1), (2), (3) y tus operaciones escritas. Última línea, literal: "FRASES DESCRIPTIVAS: [n] · LO QUE NO SE PUEDE CONCLUIR: [n] · PUNTOS CON CIFRA: [n] · VERBOS DE CAUSA: [n]": verbo de causa: el programa como sujeto de "consiguió", "logró", "redujo", "mejoró", "gracias a", "efecto de"; tiene que ser 0.

RESTRICCIONES: Mantén "<5"; si una operación lo incluye, da un rango. No digas si el programa funciona. Si los totales no cuadran, dímelo y no los reconstruyas. No incluyas ni pidas datos de personas.

Ejemplo abreviado de salida (paso 1; cifras inventadas).

LECTURA DESCRIPTIVA. Personas en el programa: de 41 a 63. Con visita en el trimestre: del 85 % al 62 %. Mediana de HbA1c con diabetes: 7,4 % (n = 18) a 7,0 % (n = 11). Sin visita en dos trimestres: de <5 a 14. LO QUE NO SE PUEDE CONCLUIR. 1. Sin grupo de comparación, la HbA1c (7,4 % a 7,0 %) pudo bajar por lo mismo que en quien no está en el programa. [...] 3. Faltan 7 de 18: si son los que iban peor, la mediana baja sin que nadie mejore. 6. Estación del año: no se ve aquí. FRASES DESCRIPTIVAS: 5 · LO QUE NO SE PUEDE CONCLUIR: 9 · PUNTOS CON CIFRA: 6 · VERBOS DE CAUSA: 0

Qué revisar antes de usarla. Dos sumas y una mediana a mano. Si no para en el paso 0, no leas el 1. Busca "gracias", "logró", "efecto", "mejora", "contribuido" y "parece haber": el recuento dice cero y a veces miente.

Lee la lista 2 antes que la 1: es la que vale y nadie la pide en la reunión. La regresión a la media no es una excusa: es lo que pasa cuando seleccionas a quien está peor (Barnett 2005).

Quien no vuelve suele ser quien no mejora: una mediana que baja mientras el n cae es una lista de llamadas, no una mejora. Pregunta qué tratamientos se empezaron en esos meses: la máquina no lo sabe y tú sí. "Sin visita en dos trimestres" no es un dato: son personas, y la llamada del capítulo 6 (caso 5) es para ellas. Quiénes son lo dice tu historia clínica, con el listado que nunca salió del centro; ni la tabla ni el chat lo saben, y así tiene que seguir.

Riesgo principal y mitigación. Presentar el antes y después como efecto del programa, con celdas que dejen adivinar quién es quién. Mitigación: la lista de lo que no se puede concluir; "<5" puesto por ti, también en las medias con menos de 5 personas; nunca el listado, solo tablas.

Caso 6 · La alerta mensual de evidencia para el equipo [AP]

Momento: docencia. **Herramienta:** una alerta de PubMed (My NCBI) como fuente; un asistente de consumo para clasificar.

Situación. Lo honesto primero: la alerta fiable y gratuita es la de PubMed. Guardas una búsqueda en My NCBI y cada mes llega un correo. La IA no busca aquí: clasifica lo que trae la alerta, con una regla tuya, en una página para la sesión. Son resúmenes de PubMed, sin datos de nadie; se citan, no se copian. Pégalos sin la cabecera del correo: tu dirección es un dato.

ROL: Eres una documentalista clínica que resume resúmenes para un equipo de Atención Primaria. No has leído los artículos: solo lo que te pego.

CONTEXTO: Te pego los resúmenes de mi alerta mensual de PubMed sobre obesidad en adultos (título, autores, revista, DOI, resumen), sin la cabecera del correo. Sin datos de nadie. REGLA DE RELEVANCIA: PUEDE CAMBIAR LO QUE HAGO = las cuatro a la vez: ensayo aleatorizado, revisión sistemática o guía; en adultos; con desenlace clínico; algo que se hace desde Atención Primaria en España. CONVIENE SABERLO = estudio observacional o desenlace intermedio que puede aparecer en consulta. NO APLICA = animales, laboratorio, técnica quirúrgica o de unidad especializada, o población que no atiende.

TAREA: (1) Clasifica cada resumen con la REGLA; para PUEDE CAMBIAR LO QUE HAGO, las cuatro condiciones con SÍ o NO. (2) Para cada uno: primer autor, año, revista, DOI; una línea con qué se estudió y en quién; otra con el resultado principal y su cifra si el resumen la da; y la etiqueta. (3) Ordena: PUEDE CAMBIAR LO QUE HAGO, CONVIENE SABERLO y NO APLICA solo con título y DOI.

FORMATO: (0) Una línea: "RESÚMENES SIN DATOS" o "TEXTO CON DATOS: BORRA ESTA CONVERSACIÓN" si el pegado contiene un correo, un usuario o cualquier dato de una persona; los autores no lo son; en ese caso, para. Después, una página: máximo 350 palabras sin contar la lista NO APLICA, sin negritas, titulada "Evidencia del mes · [MES Y AÑO]" y debajo esta línea, literal: "Resumen de resúmenes: nadie ha leído aún los artículos. Antes de cambiar nada, se lee el artículo entero." Última línea, literal: "RECIBIDOS: [n] · PUEDE CAMBIAR LO QUE HAGO: [n] · CONVIENE SABERLO: [n] · NO APLICA: [n] · SIN DOI: [n]": los tres del medio suman el primero.

RESTRICCIONES: Solo lo que está en los resúmenes: no completes con lo que sepas ni añadas estudios. No inventes DOI ni cifras: si faltan, "SIN DOI" o "sin cifra en el resumen". Sin nombres comerciales: principio activo o clase. Sin recomendaciones. No incluyas ni pidas datos de personas.

Ejemplo abreviado de salida (ejemplo inventado).

RESÚMENES SIN DATOS Evidencia del mes · [mes y año] Resumen de resúmenes: nadie ha leído aún los artículos. Antes de cambiar nada, se lee el artículo entero. PUEDE CAMBIAR LO QUE HAGO. [Primer autor], [año], [revista], doi:[del resumen]. Ensayo aleatorizado en adultos con obesidad y artrosis de rodilla, en Atención Primaria; menos dolor a los 12 meses con ejercicio supervisado, [cifra del resumen]. Cumple: ensayo SÍ · adultos SÍ · desenlace clínico SÍ · se hace en Atención Primaria SÍ. RECIBIDOS: 9 · PUEDE CAMBIAR LO QUE HAGO: 1 · CONVIENE SABERLO: 3 · NO APLICA: 5 · SIN DOI: 0

Qué revisar antes de usarla. Que los números sumen. Cada DOI de "PUEDE CAMBIAR LO QUE HAGO", en el navegador, y ese artículo se lee entero con el caso 3 antes de la sesión: uno o dos al mes, y eso cabe.

Si todo sale "CONVIENE SABERLO", mira en qué condición ha puesto NO: la regla es blanda ahí. Lo de después de una cirugía bariátrica es tuyo (capítulo 5): no lo mandes a NO APLICA. Las búsquedas

programadas de tu asistente, si las tiene, son la segunda alerta: la de PubMed da lo que existe, sin ranking de nadie.

Riesgo principal y mitigación. Que la página se lea como "lo que hay que hacer este mes". Mitigación: la segunda línea, literal, y leer entero el uno o dos que pueden cambiar algo.

Caso 7 · Verificar las referencias de mi sesión: el protocolo

Momento: docencia. **Herramienta:** asistente de consumo, sin búsqueda; después, PubMed y el navegador.

Situación. Todo lo anterior acaba en una sesión con referencias. El capítulo 2 (caso 2) enseñó a cazar una inventada; este es el protocolo para que no se escape ninguna. El prompt convierte la lista en tabla y marca lo sospechoso; cada una se comprueba a mano y recibe su etiqueta. Así se han comprobado las referencias de este libro.

ROL: Eres una documentalista que prepara la verificación de una lista de referencias. No verificas: preparas la comprobación, que haré yo.

CONTEXTO: Te pego la lista de referencias de [por ejemplo: una sesión del centro / un artículo / un capítulo], tal como está escrita, sin datos de personas.

TAREA: (1) Una tabla con una fila por referencia y estas columnas: n; primer autor; año; revista; título; volumen y páginas; DOI; PMID; SEÑALES; COMPROBACIÓN. (2) En SEÑALES, escribe cada una de esta lista que se cumpla, y solo de esta lista: DOI que no empieza por "10." seguido de cuatro o más cifras y una barra; año dentro del DOI que no coincide con el año; DOI cuyo prefijo no es el que asocias a esa revista; PMID que no es un número de hasta ocho cifras; año y volumen que no cuadran entre sí para esa revista; revista que no conoces; autores que no asocias con ese tema; título que parece la suma de dos títulos; DOI o PMID repetido en otra fila; campo vacío, salvo PMID. Si no hay ninguna, "NINGUNA". Una señal es sospecha, no veredicto. (3) COMPROBACIÓN se deja vacía: la relleno yo con EXISTE Y COINCIDE / EXISTE CON ERRORES / EXISTE PERO TRATA DE OTRA COSA / NO EXISTE. (4) Debajo, por cada fila, una línea para pegar en PubMed: el título entre comillas y el primer autor.

FORMATO: (0) Una línea: "LISTA SIN DATOS" o "LISTA CON DATOS: BORRA ESTA CONVERSACIÓN" si el pegado contiene nombres de pacientes, fechas de visita o cualquier dato de una persona; en ese caso, para. Después la tabla y las líneas de búsqueda. Última línea, literal: "REFERENCIAS: [n] · CON SEÑALES: [n] · SIN DOI: [n] · SIN PMID: [n]".

RESTRICCIONES: No completes ningún campo vacío con lo que recuerdes: un DOI o un PMID que no está en mi lista se deja vacío. No corrijas ninguna referencia, no propongas la "correcta" ni digas que existe. No busques en internet; si tu herramienta busca sola, marca "BUSCADO" en esa fila. No incluyas ni pidas datos de personas.

Ejemplo abreviado de salida.

LISTA SIN DATOS | 2 | Martínez | 2022 | Nutr Hosp | Adaptación metabólica y... | vacío | 10.20960/nh. [...]. | vacío | campo vacío (volumen y páginas); título que parece la suma de dos títulos | [COMPROBACIÓN] | Para PubMed: "Adaptación metabólica y" Martínez REFERENCIAS: 12 · CON SEÑALES: 4 · SIN DOI: 1 · SIN PMID: 9

Qué revisar antes de usarla. Todas, también las de "NINGUNA": una inventada puede no tener señales y una real tener tres. Si en SEÑALES lees "existe" o "el DOI correcto es", bórralo: el modelo ha verificado de memoria (capítulo 2).

El orden importa: PubMed por título y primer autor; si aparece, el DOI en el navegador, y que abra ese artículo; después, que diga lo que la sesión dice que dice. "EXISTE CON ERRORES" se corrige; "EXISTE PERO TRATA DE OTRA COSA" es la peor, porque existe y se cita con confianza: se quita. De 115 referencias generadas por chat, casi la mitad no existía (Bhattacharyya 2023); con modelos más nuevos, menos, no cero (Walters 2023).

Riesgo principal y mitigación. Que "CON SEÑALES: 0" se lea como "verificado". Mitigación: la columna COMPROBACIÓN vacía hasta que la rellenas tú, y ninguna referencia entra en un documento tuyo sin que la hayas abierto. Ninguna.

Caso ilustrativo, no real: arquetipo compuesto

Esta viñeta combina varias consultas preconcepcionales de mujeres con obesidad en tratamiento farmacológico. Se modifican la edad, la paridad y el tratamiento; no hay municipio, fechas ni cifras que permitan trazar a nadie. Las búsquedas son las de los casos 1 y 4, y ninguna lleva un dato suyo.

Tiene entre treinta y treinta y cinco años, obesidad de grado II y, desde hace unos meses, un tratamiento que imita una hormona del intestino (nota del caso 3). Se llevó el guion del capítulo 6: si busca un embarazo, avísame antes de nada. Ha venido a avisar. "Doctora, queremos ir a por el bebé. ¿Lo dejo hoy, o cuándo?" Lo primero que le pregunto no lo busca ninguna herramienta: cuándo fue la última regla.

La respuesta la busco en orden, no en la máquina. Primero, CIMA: la ficha técnica de su principio activo, apartado de fertilidad, embarazo y lactancia; lo autorizado, y si hay que dejarlo con antelación, y cuánta, o solo al decidir buscarlo. Segundo, la GIRO 2024, en lo que dice de la mujer que planifica un embarazo [FALTA: apartado y página]. Tercero, PubMed, para lo que la ficha no contesta.

Esa la formulo con el caso 1, sin ella dentro: exposición inadvertida a esta clase de fármacos en el primer trimestre; qué se sabe y qué no.

Lo que hay, cuando escribo esto, son cohortes y registros, casi todos en mujeres con diabetes y a otras dosis, recientes y con certeza baja, y ningún ensayo, porque no puede haberlo: un metaanálisis de siete cohortes no encuentra más malformaciones mayores tras la exposición en el primer trimestre, con un intervalo que no lo descarta (Uysal 2026; Dao 2024; Cesta 2024). Eso también es una respuesta, y se dice.

Ella trae algo leído: "He visto que no pasa nada si te quedas embarazada tomándolo". Caso 4, dos minutos: detrás del titular hay un registro pequeño (Dao 2024), y "no se ha visto" se había convertido en "no pasa". Dos frases: qué se ha visto, en cuántas, y qué falta por saber.

Lo que le digo sale de la ficha y de la guía. Se deja antes de buscar el embarazo, con la antelación que dice la ficha si la da y, si no, al decidir buscarlo; y lo planificamos juntas. Si se queda embarazada antes de tiempo, lo deja ese mismo día y me avisa: con lo que se sabe hoy, la exposición de las primeras semanas no es motivo de alarma por sí sola ni de ninguna decisión precipitada, y lo vemos con obstetricia.

Dos cosas que no esperan: el ácido fólico empieza hoy, y la cita con la matrona para la consulta preconcepcional la pido hoy; un embarazo con obesidad de grado II se acompaña desde antes. Y lo del capítulo 6: al dejar el tratamiento el peso tiende a volver, y no es culpa.

La anticoncepción hasta entonces y el resto de la consulta preconcepcional van al capítulo 8 y se deciden con ella; cuándo se retoma, tras el embarazo y la lactancia, se decide entonces. Y la frase de siempre: nada que permita saber quién es usted entra nunca en esas herramientas. Entró una pregunta general, un principio activo y un titular.

Se va con una fecha aproximada, el ácido fólico empezado, la cita pedida y la lista de lo que no se sabe. La máquina desenterró en cinco minutos lo que antes era una tarde. Leerlo y decírselo bien fue mío. No es falta de voluntad. Es biología, y es un calendario. Las dos cosas se planifican.

En 60 segundos

1. La evidencia no está más lejos: está más enterrada. La máquina desentierra en minutos; decidir qué vale y qué cambia el lunes es tuyo.
2. Cuatro herramientas para cuatro cosas: orientarse, encontrar, leer lo tuyo, verificar. Sin enlaces, la cita es de memoria.
3. Un ensayo se lee con plantilla y cada cifra lleva página; sin página, no existe. Entero solo con licencia abierta; si no, el resumen.
4. Lo que no se puede concluir de tus datos vale más que lo que se puede; la máquina lo lista si se lo pides.
5. Ninguna referencia entra en un documento tuyo sin que la hayas abierto. Ninguna.

Hazlo hoy • 10 minutos

1. **(2 min)** Escribe la última duda de consulta que no buscaste y pásala por el caso 1. Solo la pregunta.
2. **(3 min)** Crea una cuenta en My NCBI y guarda esa cadena de búsqueda con alerta mensual.
3. **(4 min)** Pega las referencias de tu última sesión en el caso 7 y comprueba a mano las dos con más señales.
4. **(1 min)** Guarda los dos con la ficha del capítulo 4: v1, fecha, modelo, iniciales.

El próximo estudio del telediario llegará antes que el artículo, como siempre. Ahora el artículo llega en dos minutos. Los diez siguientes son tuyos, y ninguna herramienta los hace por ti.

Referencias

Volumen de la literatura y pregunta de búsqueda

1. Landhuis E. Scientific literature: information overload. *Nature*. 2016;535(7612):457-8. doi:10.1038/nj7612-457a
2. Richardson WS, Wilson MC, Nishikawa J, Hayward RS. The well-built clinical question: a key to evidence-based decisions. *ACP J Club*. 1995;123(3):A12-3. doi:10.7326/ACPJC-1995-123-3-A12
3. Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn't. *BMJ*. 1996;312(7023):71-2. doi:10.1136/bmj.312.7023.71
4. National Library of Medicine. PubMed y My NCBI [Internet]. Bethesda (MD): NLM [consultado el 15 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov> y <https://account.ncbi.nlm.nih.gov>

Lectura crítica de ensayos

5. Schulz KF, Altman DG, Moher D; CONSORT Group. CONSORT 2010 statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. *BMJ*. 2010;340:c332. doi:10.1136/bmj.c332
6. Cabello JB, editor. Guías CASPe de lectura crítica de la literatura médica. Alicante: CASPe; 2005. Plantilla: 11 preguntas para entender un ensayo clínico, v1.0 [consultado el 15 de septiembre de 2026]. Disponible en: https://redcaspe.org/plantilla_ensayo_clinico_v1_0.pdf
7. Garvey WT, Batterham RL, Bhatta M, Buscemi S, Christensen LN, Frias JP, et al.; STEP 5 Study Group. Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity: the STEP 5 trial. *Nat Med*. 2022;28(10):2083-91. doi:10.1038/s41591-022-02026-4. PMC9556320. Registro: NCT03693430. Acceso abierto (© 2022 The Author(s)) [VERIFICAR licencia CC BY 4.0 en la última página del PDF]
8. Wilding JPH, Batterham RL, Calanna S, Davies M, Van Gaal LF, Lingvay I, et al.; STEP 1 Study Group. Once-weekly semaglutide in adults with overweight or obesity. *N Engl J Med*. 2021;384(11):989-1002. doi:10.1056/NEJMoa2032183. Artículo de pago; resumen libre en PubMed.
9. Wilding JPH, Batterham RL, Davies M, Van Gaal LF, Kandler K, Konakli K, et al. Weight regain and cardiometabolic effects after withdrawal of semaglutide: the STEP 1 trial extension. *Diabetes Obes Metab*. 2022;24(8):1553-64. doi:10.1111/dom.14725. PMC9542252. Acceso abierto (© 2022 The Authors) [VERIFICAR licencia Creative Commons en el PDF, y número y páginas]
10. Barnett AG, van der Pols JC, Dobson AJ. Regression to the mean: what it is and how to deal with it. *Int J Epidemiol*. 2005;34(1):215-20. doi:10.1093/ije/dyh299

Referencias fabricadas por modelos de lenguaje

11. Bhattacharyya M, Miller VM, Bhattacharyya D, Miller LE. High rates of fabricated and inaccurate references in ChatGPT-generated medical content. *Cureus*. 2023;15(5):e39238. doi:10.7759/cureus.39238
12. Walters WH, Wilder EI. Fabrication and errors in the bibliographic citations generated by ChatGPT. *Sci Rep*. 2023;13(1):14045. doi:10.1038/s41598-023-41032-5

Guías y fuentes primarias

13. Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO). Guía Española GIRO: Guía española del manejo Integral y multidisciplinaria de la Obesidad en personas adultas. 2.ª ed. Lecube A, coordinador. Madrid: SEEDO; noviembre de 2024. Disponible en: https://www.seedo.es/images/site/giro/GUIA-GIRO-2a-edicion_26NOV2024.pdf [VERIFICAR ISBN en créditos; candidato 978-84-09-65969-2; apartado sobre embarazo y página]
14. Wharton S, Lau DCW, Vallis M, Sharma AM, Biertho L, Campbell-Scherer D, et al. Obesity in adults: a clinical practice guideline. CMAJ. 2020;192(31):E875-E891. doi:10.1503/cmaj.191707
15. National Institute for Health and Care Excellence. Overweight and obesity management. NICE guideline NG246. Londres: NICE; 14 de enero de 2025. Disponible en: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng246>
16. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Centro de Información online de Medicamentos (CIMA) [Internet]. Madrid: AEMPS [consultado el 15 de septiembre de 2026]. Fichas técnicas autorizadas por principio activo, sección 4.6 (fertilidad, embarazo y lactancia). Disponible en: <https://cima.aemps.es>

Exposición en el embarazo y el estudio del titular

17. Uysal N, Horoz E, Gungor M, Timarci I, Sozmen MK, Karadas B, et al. Pregnancy outcomes following maternal GLP-1 receptor agonist exposure: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 2026. doi:10.1038/s41598-026-61582-8
18. Dao K, Shechtman S, Weber-Schoendorfer C, Diav-Citrin O, Murad RH, Berlin M, et al. Use of GLP1 receptor agonists in early pregnancy and reproductive safety: a multicentre, observational, prospective cohort study based on the databases of six Teratology Information Services. BMJ Open. 2024;14(4):e083550. doi:10.1136/bmjopen-2023-083550
19. Cesta CE, Rotem R, Bateman BT, Chodick G, Cohen JM, Furu K, et al. Safety of GLP-1 receptor agonists and other second-line antidiabetics in early pregnancy. JAMA Intern Med. 2024;184(2):144-52. doi:10.1001/jamainternmed.2023.6663
20. Vujović N, Piron MJ, Qian J, Chellappa SL, Nedeltcheva A, Barr D, et al. Late isocaloric eating increases hunger, decreases energy expenditure, and modifies metabolic pathways in adults with overweight and obesity. Cell Metab. 2022;34(10):1486-98.e7. doi:10.1016/j.cmet.2022.09.007